

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22231696632 | 112

JOSE HAMILTON DA SILVA JUNIOR

IDADE: 61 anos PESO: 68 ALTURA: 1,62 PROFISSÃO: Mecânico

SINTOMAS: sonolência diurna; Comaço Excessivo; Ronco.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Doxaprost (notita); Spiriva + Clenil (bomba) todos os dias - Bronquite; ASS

MÉDICO: Dra. Marinkla (Geriatria); Dr. Boldini (pneumo);

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 0

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h30' 23h HORA QUE ACORDA: 7h30' 8h30'

COCHILHO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO ☒ SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: II IAH: 55 e 1h SPO2: 86%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

27/02/24 Avaliação Auto 4 a 15 cmH₂O Máx suíte 1(S)

04/03 P= 4-15 cmH₂O / ↓ 4-8 cmH₂O

24 IAH= 3.3

m. de uso: 6h

Bem adaptado

diminuiu o delta de pressão

Oriento higiene da narina

Natasha

11/03 P= 4-8 cmH₂O / Fixo: 7 cmH₂O

24 IAH= 1.8

m. de uso: 5h 41'

Bem adaptado

fixo pressão 7 cmH₂O

Natasha

18/03/24 P= 7 cmH₂O

IAH= 1.9

m. de uso: 4h 17'

Bem adaptado

Orientado a lavar as VAS com soro fisiológico

Natasha

25/03/24 $P=7\text{ cmH}_2\text{O}$ $\uparrow P=7,6\text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=1,8$
m de uso: 5h 13m
fuga: 1,5
Bem adaptado
Retira máscara durante
a noite
Natacha

01/04/24 $P=7,6\text{ cmH}_2\text{O}$ Comprou a paulha
 $IAH=1,5$
m de uso: 5h 19'
fuga: 0,3 l/min
Bem adaptado
Natacha

15/04
24 $P=7,6\text{ cmH}_2\text{O}$ $\downarrow P=7,2\text{ cmH}_2\text{O}$ Pte relata desconf
 $IAH=3,8\text{ e/h}$ ao soltar o ar.
m de uso: 4h 25m
fuga: 17,3 l/min (percentil)
Bem adaptado
Natacha

20/05
24 $P=7,2\text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=1,5\text{ e/h}$ Bem adaptado
m de uso: 5h 7m
fuga: 14,3 l/min
Natacha

22/07/24 $P=7,2\text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=1,3\text{ e/h}$ Bem adaptado
m de uso: 5h 18m
fuga Pas: 13,7 l/min
Natacha

23/09/24 $P=7,2\text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=1,0\text{ e/h}$
m de uso: 3h 53 min
fuga: 16 l/min
 $\downarrow P: 70\text{ cm}$ Bem adaptado
- está dormindo pouco pq está
subconsciente mto ar - escape ??
ajuste máscara e + pressão.

22/11/24 $P=7\text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=1,3\text{ e/h}$
m de uso: 4h 35'
fuga: 14,3 l/min
Bem adaptado por
Pte relata dificuldade
p dormir em alguns dias
devido mudança de trabalho
Natacha

geni Hamilton

30/02/2025	P=7.0 cmH ₂ O IAH=1,3 e/h muro=5 h 22 min fuga=12 l/min	não usou 9 dias no mar por febre * trocou máscara Swift (S) + tubo * e filtro Silvia
04/04/25	P=7.0 cmH ₂ O IAH=1,6 cmH ₂ O muro=4h 54 min fuga=12 l/min	está dormindo pouco → vai fazer Biópsia próstata aumentada Derlize compa D sentiu melhora no conforto. Sugiro comi vibrada Silvia
17/06/25	P: 7 cmH ₂ O IAH=0,9 e/h m de uso: 4h 44 min usou 14 de 30 dias fuga: 12,3 l/min	Usou pouco aparelho pois está com problemas renais e não consegue dormir Oriento buscar psicologia Natália

Nome: JOSE HAMILTON DA SILVA JUNIOR

Data de Nascimento: 7-5-1962

IMC: 26,29

Sexo: Masculino

Data do exame: 28-01-2024

Peso: 69 kg

Altura: 1,62 m

Médico: MARISTELA SOUBINE

Medicamentos: 0

Histórico: APNEIA DO SONO

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 28-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 583,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 166,5 e 137,0 minutos. O tempo total de sono foi de 327,5 min, eficiência de 56,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 63,2%; estágio N3: 12,5%; sono REM: 22,1%. O índice de despertares foi de 24,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 55,3/hora, sendo 84 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 139 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 86%, permanecendo 2,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 79 bpm e NREM de 49 - 90 bpm.

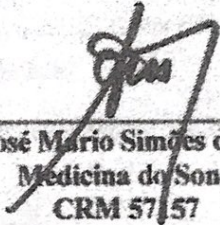
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 55,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (8,4/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.
Presença de bruxismo ou apertamento.**

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157